

TEMA 2.17 • DIABETES Y DISLIPIDEMIAS

Neuropatía Diabética

PERFIL EUNACOM 1.04.1.015

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Neuropatía Diabética

La neuropatía es una complicación microvascular crónica frecuente. El diagnóstico es **clínico**; rara vez se necesita electromiografía (solo en duda diagnóstica o previo a cirugía por atrapamiento).

Formas de Presentación

TABLA 2.17.1: TIPO VS CLÍNICA CARACTERÍSTICA	
TIPO	CLÍNICA CARACTERÍSTICA
Polineuropatía sensitiva distal simétrica	Es la más común. Distribución "en calcetín y guante" (predominio distal e inferior). Se pierde sensibilidad termalgésica y vibratoria (fuerte factor de riesgo para pie diabético). Puede atrofiar músculos distales.
Neuropatía dolorosa	Dolor de características neuropáticas: urente , asociado a alodinia (dolor con roce) e hiperalgesia .
Amiotrofia diabética	Atrofia muscular proximal (ej. cuádriceps, cintura escapular) y dolor.
Mononeuropatía por atrapamiento	Frecuente Síndrome de Túnel Carpiano (nervio mediano) o cubital.
Mononeuropatía craneal	Parálisis de pares craneales motores del ojo. 3º par (Oculomotor) es el más afectado (ojo desviado a lateral/abajo + ptosis). Puede afectar el 4º o el 6º par.

Tratamiento

- **Prevención y Prevención 2ª:**
 - - Control metabólico estricto.
 - - Cuidado de los pies, educación podológica.
- **Manejo del dolor neuropático (moduladores del dolor):**
 - - **Antidepresivos duales/IRSN:** Venlafaxina, Duloxetina.
 - - **Anticonvulsivantes / Gabaérgicos:** Pregabalina, Gabapentina.

- - **Antidepresivos Tricíclicos (TCA):** Amitriptilina. *Contraindicados en adulto mayor* (riesgo de cardiotoxicidad y delirio).
- - *Nota: Paracetamol o AINEs no sirven para dolor neuropático.*
- **Indicaciones de Insulina:**
 - - Puede plantearse en la neuropatía amiotrófica/dolorosa severa, pues mejora trofismo muscular y control metabólico rápido.
- **Neuropatía por atrapamiento:** Liberación quirúrgica.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de 60 años con DM2 de 18 años consulta por dolor urente en ambos pies que empeora en la noche, con hipoestesia en calcetín bilateral. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Neuropatía Diabética. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La neuropatía diabética es la complicación crónica más frecuente de la diabetes
- La polineuropatía simétrica distal en patrón guante-calcetín es la forma más común
- La neuropatía autonómica cardiovascular puede causar infartos silentes y muerte súbita
- Parálisis del III par craneal diabético preserva la pupila (a diferencia de la compresiva)
- Primera línea para dolor neuropático: pregabalina, gabapentina, duloxetina o amitriptilina
- El control glicémico estricto es la medida más importante para prevenir y frenar progresión
- El monofilamento de 10 g y diapasón 128 Hz son las herramientas de tamizaje

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (NEUROPATÍA DIABÉTICA)

PREGUNTA 1

Paciente de 60 años con DM2 de 18 años consulta por dolor urente en ambos pies que empeora en la noche, con hipoestesia en calcetín bilateral. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ A) Enfermedad arterial periférica
- ☐ B) Polineuropatía simétrica distal diabética
- ☐ C) Síndrome de túnel tarsiano
- ☐ D) Radiculopatía lumbar
- ☐ E) Fibromialgia

PREGUNTA 2

Paciente diabético presenta parálisis del III par craneal con ptosis y estrabismo divergente, pero con pupila reactiva normal. ¿Cuál es la causa más probable?

- ☐ A) Aneurisma de comunicante posterior
- ☐ B) Mononeuropatía diabética del III par
- ☐ C) Tumor cerebral
- ☐ D) Miastenia gravis
- ☐ E) Esclerosis múltiple

PREGUNTA 3

¿Cuál de los siguientes fármacos es de primera línea para el dolor neuropático diabético?

- ☐ A) Tramadol
- ☐ B) Ibuprofeno
- ☐ C) Pregabalina
- ☐ D) Paracetamol
- ☐ E) Morfina

RESUMEN: NEUROPATÍA DIABÉTICA

La neuropatía diabética es la complicación crónica más frecuente de la diabetes, afectando hasta al 50% de los pacientes. Se produce por daño a los nervios periféricos secundario a hiperglicemia crónica, estrés oxidativo y daño microvascular de los vasa nervorum. La forma más común es la polineuropatía simétrica distal sensitivo-motora, que afecta los pies en patrón de guante y calcetín, con síntomas que incluyen dolor urente, parestesias, hipoestesia y pérdida de reflejos aquileanos. Existen múltiples formas clínicas: polineuropatía simétrica distal (la más frecuente), neuropatía autonómica (cardiovascular, gastrointestinal, genitourinaria, sudomotora), mononeuropatía (parálisis de pares craneales III, IV, VI, nervio mediano), mononeuropatía múltiple, radiculopatía y amiotrofia diabética. La neuropatía autonómica cardiovascular es especialmente peligrosa por causar taquicardia en reposo, hipotensión ortostática, infartos silentes y muerte súbita. El diagnóstico es clínico, apoyado por el test con monofilamento de 10 g, diapasón de 128 Hz, evaluación de reflejos y estudios de conducción nerviosa en casos dudosos. El tratamiento incluye control glicémico estricto como medida más importante, y manejo del dolor neuropático con pregabalina, gabapentina, duloxetina o amitriptilina como primera línea. Los opioides se evitan. El cuidado preventivo del pie es esencial para prevenir úlceras y amputaciones.